Pure red cell aplasia	PRCA	Bất sản riêng dòng hồng cầu
Parathyroid hormone	PTH	
Renin- Angiotensin-Aldosteron System inhibitor	RAASi	Thuốc ức chế hệ thống RAA
Subjective global assessment	SGA	Đánh giá chủ quan toàn diện
Sodium-Glucose contransporter 2 inhibitor	SGLT2i	Thuốc ức chế kênh đồng vận chuyển natri-glucose týp 2
Secondary hyperparathyroidism	SHPT	Cường cận giáp thứ phát
Self Monitoring of Blood Glucose	SMGB	Tự theo dõi đường máu
Thrombotic microangiopathy	TMA	Bệnh lý vi mạch huyết khối
Transferrin saturation	TSAT	Độ bão hòa transferrin
Thiazolidinedione	TZD	
Urine albumin-to-creatinine ratio	uACR	Tỉ số albumin/creatinine niệu
Urine protein-to-creatinine ratio	uPCR	Tỉ số protein/creatinine niệu
Urine albumin excretion	UAE	Lượng albumin niệu
Urine protein excretion	UPE	Lượng protein niệu
Ultrafiltration	UF	Siêu lọc
Ultrafiltration failure	UFF	Suy siêu lọc

ngoctv_hdb_trunghoc_tran_thuong_12/08/2024 16:39:41

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Bảng quy đổi đơn vị 16
Bảng 2. Sức mạnh khuyến cáo và mức độ bằng chứng theo KDIGO 16
Bảng 3. Các nhóm nguyên nhân gây bệnh thận mạn theo vị trí tổn thương 17
Bảng 4. Một số bệnh lý thận do ung thư và thuốc điều trị ung thư 17
Bảng 5. Các công thức ước tính chức năng lọc cầu thận dựa vào creatinin máu 23
Bảng 6. Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh thận mạn 25
Bảng 7. Các giai đoạn của BTM theo KDIGO 2012 và đồng thuận 2014 25
Bảng 8. Các nhóm albumin/protein nước tiểu 26
Bảng 9. Phân giai đoạn, phân tầng nguy cơ và tần suất tái khám hàng năm theo KDIGO 2024 27
Bảng 10. Mục tiêu quản lý BN BTM bởi bác sĩ không chuyên khoa Thận và chuyên khoa Thận 33
Bảng 11. Các khuyến cáo về mức huyết áp mục tiêu cho người mắc BTM 35
Bảng 12. Chỉnh liều một số thuốc ƯCMC và ƯCTT trong BTM 37
Bảng 13. Tần suất và xét nghiệm theo dõi tình trạng thiếu máu ở BTM 39
Bảng 14. Một số chế phẩm sắt uống 40
Bảng 15. Một số chế phẩm sắt truyền tĩnh mạch 41
Bảng 16. Sử dụng thuốc kích thích tạo hồng cầu 41
Bảng 17. Liều thuốc ức chế DPP-4 hàng ngày theo chức năng thận 46
Bảng 18. Nguy cơ hạ đường máu của các thuốc điều trị ĐTĐ 47
Bảng 19. Các rối loạn lipid máu ở các nhóm BTM 47
Bảng 20. Liều các thuốc statin sử dụng trong BTM 48
Bảng 21. Liều khuyến cáo cho các thuốc hạ acid uric máu ở BTM. 52
Bảng 22. Thuốc chỉ định điều trị cơn gút cấp và chỉnh liều trong BTM 52
Bảng 23. Các chỉ dấu của cường cận giáp thứ phát do thận 53
Bảng 24. Hệ thống TMV phân loại loạn dưỡng xương do thận 53
Bảng 25. So sánh các nhóm thuốc gắn phosphate 55
Bảng 26. Nồng độ mục tiêu của canxi, phosphate và PTH 56
Bảng 27. Kiểm soát CKD-MBD theo giai đoạn BTM 56
Bảng 28. Phân loại cơ chế gây toan chuyển hóa 61
Bảng 29. Phân loại toan chuyển hóa với khoảng trống anion bình thường 64
Bảng 30. Tiêu chuẩn tổn thương thận cấp theo KDIGO 2012 69
Bảng 31. Ý nghĩa các xét nghiệm sàng lọc nhiễm virus viêm gan B 71
Bảng 32. Tiêu chuẩn chẩn đoán các thể bệnh nhiễm viêm gan virus B mạn 72
Bảng 33. Lựa chọn thuốc kháng virus trong điều trị VGB kháng thuốc 76

ngoctb_KCB_thong Lê Văn Ngọc – 19/06/2024 16:39:41

Bảng 34. Liều thuốc nucleoside analogues (NA) điều trị viêm gan B mạn 76
Bảng 35. Các phác đồ thuốc DAA điều trị viêm gan C theo giai đoạn BTM 79
Bảng 36. Các yếu tố nguy cơ tiến triển suy thận giai đoạn cuối 83
Bảng 37. Tiếp cận phát triển chương trình tư vấn và giáo dục cho BN mắc BTM..... 84
Bảng 38. Một số thuốc có nguy cơ gây độc thận 106
Bảng 39. Chỉ định sử dụng thuốc cản quang tĩnh mạch 111
Bảng 40. Khuyến cáo về sử dụng thuốc cản quang chứa iod 112
Bảng 41. Phân loại thuốc TĐQTCG dựa theo nguy cơ NSF 115
Bảng 42. Chỉnh liều một số thuốc kháng sinh theo độ thanh thải creatinine (CrCl)... 118
Bảng 43. Các tác nhân gây nhiễm trùng thường gặp ở bệnh nhân BTM 123
Bảng 44. Khuyến cáo về tiêm chủng cho người mắc BTM 126
Bảng 45. Liều thuốc đồng vận thụ thể GLP-1 cho BN mắc BTM 134
Bảng 46. Phân loại viêm thận lupus theo ISN/RPS 2004 139
Bảng 47. Các biện pháp làm giảm nhẹ/ 140
Bảng 48. Các phác đồ liều glucocorticoids cho BN viêm thận Lupus 143
Bảng 49. Các phác đồ liều Cyclophosphamide phối hợp glucocorticoids để điều trị tấn công viêm thận lupus hoạt động nhóm III/IV 144
Bảng 50. Phân loại đáp ứng điều trị trong viêm thận Lupus 145
Bảng 51. Phân biệt một số bệnh liên quan viêm mạch máu nhỏ 167
Bảng 52. Một số phác đồ ức chế miễn dịch tấn công trong VCT liên quan ANCA ... 169
Bảng 53. Một số phác đồ ức chế miễn dịch duy trì trong VCT liên quan ANCA 170
Bảng 54. Phác đồ điều trị VCT do kháng thể kháng màng đáy 175

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Sơ đồ chẩn đoán THA với các phương pháp đo HA tại phòng khám..... 35
Hình 2. Sơ đồ chẩn đoán nhiễm toan máu..... 65
Hình 3. Tiếp cận toàn diện để cải thiện kết cục của bệnh nhân ĐTĐ và BTM..... 131
Hình 4. Các yếu tố cần cân nhắc khi đặt mục tiêu HbA1C..... 133
Hình 5. Lựa chọn thuốc hạ đường máu cho bệnh nhân ĐTĐ týp 2 và BTM..... 134
Hình 6. Chỉnh liều metformin theo chức năng thận..... 134
Hình 7. Sơ đồ chẩn đoán viêm thận lupus..... 138
Hình 8. Sơ đồ điều trị ức chế miễn dịch cho viêm thận Lupus nhóm I hoặc II 141
Hình 9. Sơ đồ điều trị tấn công cho viêm thận Lupus hoạt động nhóm III/IV 142
Hình 10. Sơ đồ điều trị duy trì cho viêm thận Lupus nhóm III và nhóm IV..... 145
Hình 11. Sơ đồ điều trị viêm thận Lupus nhóm V 145
Hình 12. Sơ đồ điều trị viêm thận lupus kèm bệnh vi mạch huyết khối. 146
Hình 13. Sơ đồ tiếp cận chẩn đoán viêm cầu thận liên quan ANCA 166
Hình 14. Sơ đồ điều trị viêm cầu thận liên quan ANCA..... 171

ngoctlv-cdt.trung.se.vn tuyen truoc 12/08/2024 16:39:41

Bảng 1. Bảng quy đổi đơn vị

Giá trị	**Đơn vị truyền thống**	**Hệ số chuyển đổi**	**Đơn vị quốc tế SI**
Tỉ số albumin / creatinine (ACR)	mg/g	0,113	mg/mmol
Tỉ số protein / creatinine (PCR)	mg/g	0,113	mg/mmol
Creatinine	mg/dL	88,4	µmol/l
BUN (nitơ trong ure máu)	mg/dL	0,357	Ure (mmol/l)
Phosphate	mg/dL	0,3229	mmol/l
Calci	mg/dL	0,2495	mmol/l
Urate	mg/dL	59,48	µmol/l
Đơn vị SI = Đơn vị truyền thống X Hệ số chuyển đổi			

ngoctlv_kcb_Phương Lê Văn Ngọc_12/08/2024 16:39:41

Bảng 2. Sức mạnh khuyến cáo và mức độ bằng chứng theo KDIGO

Sức mạnh khuyến cáo	**Ý nghĩa**
Mức 1: khuyến nghị	Với bác sỹ: phần lớn bệnh nhân nên được thực hành theo
Mức 2: gợi ý	Với bác sỹ: cân nhắc cá thể hóa tùy vào mỗi trường hợp cụ thể
Mức độ bằng chứng	**Ý nghĩa**
A: cao	Hiệu quả thực sự rất gần với kết quả ước tính trong nghiên cứu
B: trung bình	Hiệu quả thực sự có khả năng rất gần với kết quả nghiên cứu, nhưng có thể có sự khác biệt nhất định
C: thấp	Hiệu quả thực sự có thể khác biệt đáng kể so với kết quả nghiên cứu
D: rất thấp	Kết quả nghiên cứu không chắc chắn và có thể khác biệt lớn so với hiệu quả thực sự.

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THẬN MẠN

ngoctlv.ktyhcm_Thương Lê Văn Ngọc_1/10/2024 16:39:41

1. ĐẠI CƯƠNG

Bệnh thận mạn (BTM) được định nghĩa là các bất thường về cấu trúc hoặc chức năng của thận kéo dài trên 3 tháng do bất kỳ nguyên nhân nào dẫn tới những tác động về sức khỏe người bệnh.

2. NGUYÊN NHÂN

2.1. NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH THẬN MẠN

Bảng 3. Các nhóm nguyên nhân gây bệnh thận mạn theo vị trí tổn thương

Các nhóm nguyên nhân bệnh thận mạn	
Bệnh mạch thận	Bệnh lý vi mạch (microangiopathy diseases)
	Bệnh lý mạch máu lớn (macroangiopathy diseases)
Bệnh cầu thận	Nguyên phát
	Thứ phát
Bệnh ống-kẽ thận	Nguyên phát
	Thứ phát
Bệnh lý tiết niệu	Nhiễm trùng đường tiết niệu
	Tắc nghẽn đường tiết niệu, trào ngược bàng quang niệu quản
	Sỏi tiết niệu
	Dị dạng đường tiết niệu

Ngoài ra, bệnh lý thận trong ung thư được tách riêng thành một chuyên ngành, bao gồm người bệnh thận mắc ung thư hoặc người ung thư mắc bệnh thận. Tổn thương thận cấp (TTTC) và BTM làm tăng di chứng và tử vong ở tất cả BN, kể cả người bị bệnh ung thư; người bệnh ung thư có các rối loạn đặc trưng của ung thư kèm các biểu hiện của bệnh thận và tần suất BTM và ung thư cao, tuổi thọ của người bệnh ngày càng cải thiện, vì vậy cần có bác sĩ chuyên khoa Thận trong đội ngũ chăm sóc người bệnh ung thư. Tổn thương thận trong ung thư thường là hỗn hợp thông qua nhiều cơ chế khác nhau.

Bảng 4. Một số bệnh lý thận do ung thư và thuốc điều trị ung thư

Bệnh lý	**Hay gặp**	**Ít gặp**
Leukemia	TTTC do nhiễm khuẩn, giảm thể tích, ngộ độc thuốc	Bệnh thâm nhiễm, viêm cầu thận, TTTC do hội chứng tiêu khối u